

ДИСКУССИЯ · 26 АВГУСТА · 14.00–15.30 · ПЛОЩАДКА № 2

Организация питания: опыт реализации проектов

Не просто накормить — как право выбора доходит до тарелки

МОДЕРАТОРЫ ДИСКУССИИ

Евгений Чистяков · директор ДСО «Серафимовский», Санкт-Петербург

Тимур Нурбаев · директор ДСО «Тесовый берег» — площадка № 2
семинара

Разговор о трёх конфликтах

1

Выбор или безопасность?

вопросы 1 и 5 программы: субъектность жителя, недееспособность, медицинские рамки



2

Вариативность или норматив и бюджет?

вопросы 2, 4 и 6: меню в нормах, «лечебность», качество против цены



3

Единое меню или индивидуальная поддержка?

неговорящие, постельные, особые пищевые биографии



Шесть вопросов программы — внутри этих трёх конфликтов. Дословные формулировки — в памятке и на резервном слайде.

2 190

 завтрак

 2-й завтрак

 обед

 полдник

 ужин

 2-й ужин

× 365

приёмов пищи на жителя в год — в ДСО «Серафимовский» **шесть приёмов в день**. Каждый из них — решение, принятое за человека.

Около 74 % жителей российских ПНИ недееспособны

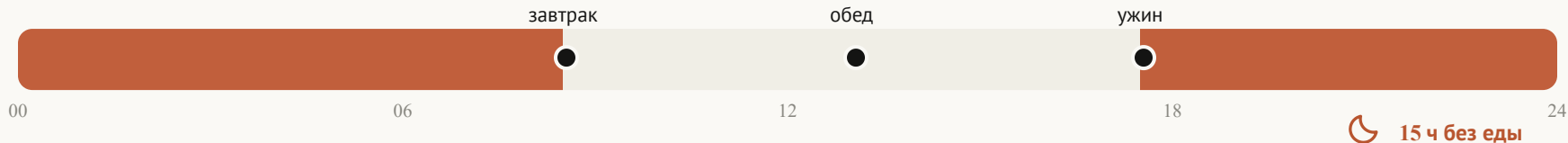


По агрегированным данным о российских ПНИ за 2024 год. В конкретном учреждении доля может существенно отличаться — посчитайте свою.

Сделки совершает опекун (ст. 29 ГК). Повседневное предпочтение обычно не сделка — а мнение недееспособного выяснять и учитывать обязательно. Кто не говорит — показ, наблюдение, биография.

Источник: проект «Если быть точным» (публикация 09.04.2026), данные за 2024 год — агрегированные, не статотчётность Минтруда. Ст. 29 ГК · 48-ФЗ.

Пример: ужин 17:30 → завтрак 8:30 = 15 часов



Швеция — ориентир



11 ч

США — норма CMS



14 ч

Пример расписания



15 ч

Арифметика возможного графика, не обследование РФ. Швеция и США — нормы разных систем регулирования: определения приёма и перекусов различаются, прямое сравнение ограничено. Замер фактического интервала своего дома — по каждому режиму и с учётом позднего перекуса — отвечает лучше любого слайда.

Вопрос залу: какая цифра в вашем доме? Замер — три дня, одна строка в журнале, ноль рублей.

Запрета на выбор нет. Прямой обязанности — тоже

442-ФЗ



Учёт индивидуальных потребностей позволяет включить пищевые предпочтения в ИППСУ. Это не буквальное право на ежедневный выбор из нескольких блюд.

3185-1 и ГК



Ст. 43 — статус проживающих. Ст. 29 ГК — опекун учитывает мнение. Повседневное предпочтение обычно не сделка.

СанПиН



Не менее 3 приёмов, диетическое по показаниям. Число вариантов блюд нормы не ограничивают.

С 01.09.2026 — СанПиН 2.3/2.4.4282-26. На даты семинара ещё 3590-20. Ответ проверяющему — комплект документов, не формула «не запрещено».

Это уже делают. Шесть публичных историй, 2024–2026



Болотнинский ПНИ · Новосибирская обл.

2024 · два вторых блюда на старте



Успенский ПНИ · Новосибирская обл.

2024 · выбор во всех отделениях



Усть-Илимский ДСО · Иркутская обл.

2024 · опрос предпочтений → выбор



Иркутская область · масштаб региона

2025 · решение для всех учреждений



Серафимовский ДСО · Санкт-Петербург

2025–2026 · заказное питание



Тесовый берег ДСО · Санкт-Петербург

фарфор, линия раздачи — со-модератор

Ни один кейс не начинался с «сначала дайте деньги и разрешение».

Наш кейс: житель заказывает ужин накануне

ЧТО СДЕЛАЛИ



Несколько месяцев часть жителей выбирала рацион следующего дня по меню. Заказ — накануне, к вечеру известно, что готовить.

Жители приняли выбор с энтузиазмом. Директор — я: рассказываю и про цену, и про пределы.

Выбор закреплён в правилах дома

Приказ № 124 от 10.03.2026

«Об утверждении правил внутреннего распорядка жителей»



ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ

Заказное питание (вариативное меню) — норма внутреннего распорядка, а не «эксперимент по новости». Включая маломобильных: приём пищи в жилых комнатах, помощь в кормлении.

Опора перед проверяющими: «это правила дома, утверждённые приказом» — пережили смену настроения.

Слово со-модератору

ТИМУР НУРБАЕВ

директор ДСО «Тесовый берег»,
Санкт-Петербург · площадка № 2 — его дом

ЧТО УЖЕ ВИДНО В «ТЕСОВОМ БЕРЕГЕ»

-  фарфор вместо железных мисок
-  вилки и ножи на столе
-  самообслуживание: поднос и линия раздачи
-  тренировочная кухня — доступ круглосуточно

Два модератора — один разговор: мой блок — вариативность и право выбора; дальше — общая дискуссия по шести вопросам.

Вопрос 1. Три слоя ответа

Право



Запрета на выбор нет; прямой обязанности — тоже. Опекун учитывает мнение (ст. 29 ГК). Это не милость кухни.

Процедура



кто и как фиксирует выбор: журнал, совет, опекун — роль каждого

Культура



«за него решили» → «у него спросили» — самый медленный и главный слой

Обновлённая программа: «руководитель», не «хозяин». Учреждение организует выбор, а не владеет волей.

Норма ограничивает набор. Не выбор

∞ Гречка ↔ рис ↔ пшено

🔍 Курица ↔ индейка

🐟 Треска ↔ хек

Таблицы замены в раскладках — существующий законный механизм: равноценная замена внутри группы продуктов.

Норма — рамка содержимого тарелки, а не число тарелок.

ЧТО ЭТО СТОИТ

Сырьё пары сопоставимо — копейки на порцию.

Реальная цена — труд и порядок: журнал заказа, вторая гастрорёмкость, обучение смены.

Вопрос 3. «Лечебное» — не кухня, а врач

ЧТО ГОВОРЯТ НОРМЫ



Приказы о лечебном питании (330н, 395н) адресованы медицинским организациям.

Для ДСО: 3 приёма + диетическое по показаниям.

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ



«Лечебность» руками кухни — диагноз повара. Диагнозы ставит врач.

Самовольная «диетизация» — риск и для здоровья, и для проверки.

Позиция доклада: обычное питание + диетическое по показаниям. «Лечебное всем» — имитация стандарта.

«Лечебное» × «вариативное» — не враги



Рецепт: врач задаёт стол — внутри него всегда есть пары. Так работает дом в Московской области (распоряжение 19РВ-32).

Выбор не требует дееспособности. Каналы воли

1

Показ двух порций

выбор глазами и рукой



2

Наблюдение за съеденным

что осталось — то и сигнал



3

Пищевая биография

привычки всей жизни



4

«Те, кто знает»

персонал, родные, опекун



Замещающее решение («мы знаем лучше») Комитет по правам инвалидов признаёт несовместимым со ст. 12 КПИ. Граница — медицина: «два безопасных» вместо «одно назначенное». Текстуру назначает врач; IDDSI — язык описания консистенции, не само назначение.

Нормируя цену порции, управляем меньшей частью денег



Полная стоимость обеда в 3–6 раз выше сырьевой строки (канадский аудит стационаров).

Экономить надо на потерях — отходы, срывы поставок, картельные наценки, — а не на белке в тарелке.

Три ошибки дорожке бездействия

1



Имитация выбора

«Выбирайте!» — при одном блюде на линии. Хуже честного мономеню: обманывает журнал и проверяющего.

2



Выбор без гарантии

Житель выбрал Б — Б закончилось. Нет стандартного варианта — нет системы, есть лотерея.

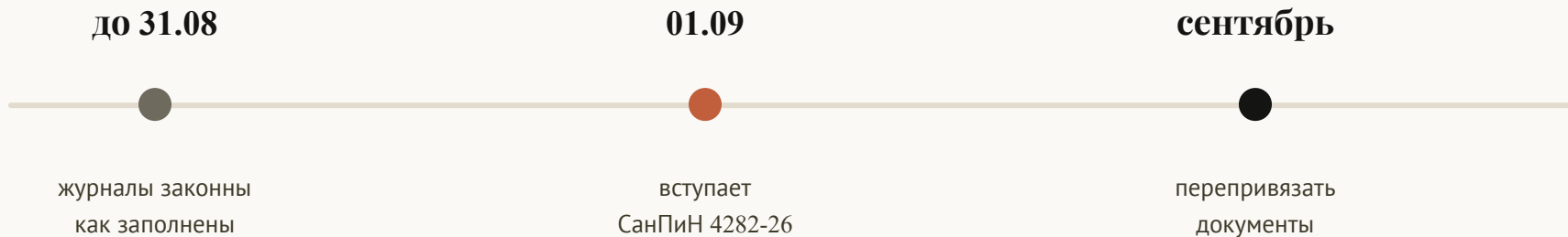
3



«Лечебность» без врача

Кухня назначает столы сама. Диагноз от повара — риск здоровью и дело по ст. 6.6 КоАП.

С 01.09.2026 — новый СанПиН. Без паники



Перепривязать: положение о питании, формы журналов (приложения 4–5 нового СанПиН), ППК и ХАССП. Переходного периода нет.

Число вариантов блюда не ограничено ни в одной редакции правил.

Три шага с понедельника. Без денег и разрешений

Не меняйте всё меню: один обед · одно отделение · одна неделя.

Замер



7 дней: ночной интервал, отходы, кто выбирал. Одна страница, ноль рублей.

Один вариант



выбора

Одна позиция, одно отделение, два блюда. Журнал заказа — тетрадь.

Правило трёх



отказов

Три отказа подряд — врач сегодня.
Поперхнулся — врач немедленно.

Через 90 дней у вас будут числа. С ними идут и к учредителю, и к проверяющему.

Что должно измениться

У каждого жителя есть безопасный способ выразить предпочтение, получить доступный вариант и быть услышанным при отказе от еды.

Учреждение может документально показать весь путь этого решения: профиль → заказ → тарелка → съедено → замена.

Это не лозунг, а проверяемая формула: каждая часть — число в панели пяти показателей.



**Тарелка — самое частое решение,
которое дом принимает за жителя.
Вернуть его жителю — самое простое
из всех прав, что у нас есть.**

*Право выбора становится реальным тогда,
когда его можно проследить до тарелки.*

Основной показ закончен

Дальше — резерв для ответов: разогрев, лестницы, голосования, IDDSI, закупки, смежные площадки, материалы.

На 90 минут достаточно слайдов 1–21. Остальное — если зал спросит.



Вспомните вчерашний ужин. Поднимите руку, если хоть один житель вашего дома мог выбрать второе блюдо.

Рука, которая не поднимается, — это и есть повестка наших 90 минут.

Честное «никто не мог» — нормальный старт, а не провал.

Единственный, кто ест, — вне цепочки решений



ЖИТЕЛЬ

— единственный, кто ест, — в этой цепочке не участвует. Его предпочтение — не вход, а помеха: «не ест это», «опять перловка».

Дискуссия начинается ровно здесь: вопрос № 1 программы — «кто выбирает?»

Честно о цене и о пределе

ЧТО ЭТО СТОИЛО



Дополнительное оборудование и ставки пищеблока.

Старт **не был бесплатным** — говорю это прямо.

ГДЕ СЛОМАЛОСЬ



Полный переход труден: нормы сбалансированности, здоровье, тяга к популярному, но бесполезному.

Ответ — пары эквивалентов, а не запрет.

Универсального «бесплатного старта» нет — это калибрует ожидания зала.

Лестница вариативности: пять ступеней вверх



Ступени 1–2 подтверждены практикой 2024–2025 годов. Ступени 3–5 — горизонт, а не требование.

Вторая ось: сколько контроля вернулось жителю

0

Выбора нет — еда определена чужими решениями

1

Спросили — но тарелка та же

2

Его выбор дошёл до тарелки сегодня

3

Выбрал ещё время и место еды

4

Влияет на меню через совет жителей

5

Еда снова часть жизни: кухня, гости, биография

Проект поднимает сразу по двум осям — ступень следует выбирать по жителю, а не по бюджету.

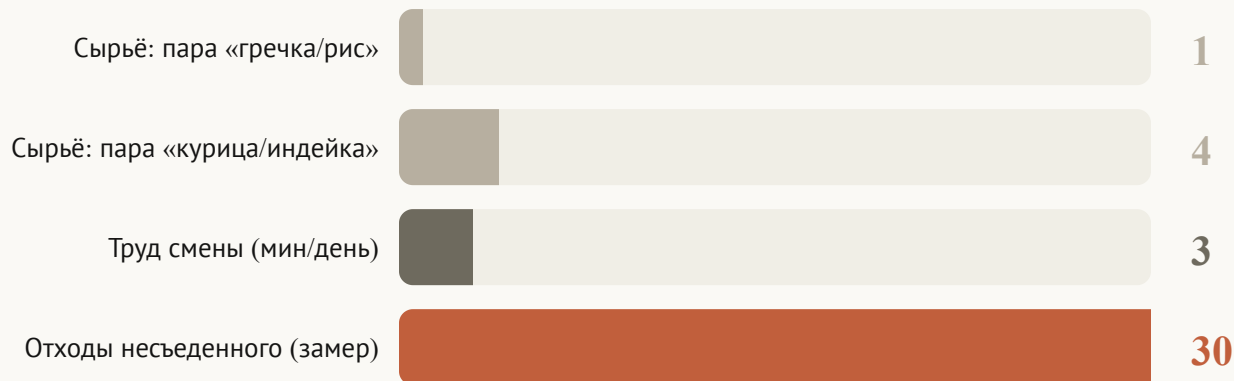


Кто в вашем доме сегодня отвечает на вопрос «что сегодня на обед»?

Поднимите руку: кухня? диетсестра? директор? совет жителей? сам житель?

В большинстве домов ответ — «раскладка три года назад». Это и есть первый кандидат на изменение.

Что действительно стоит второй вариант



Настоящая статья потерь — то, что лежит в тарелках несъеденным.

Калькулятор (приложение 42) считает вашу пару за вечер: цена кг и масса порции. Никаких «общих цифр» — только ваш замер.



Что дороже: второй вариант на линии — или тарелки, которые уносят несъеденными?

Замер отходов за 7 дней отвечает на этот вопрос в рублях. У кого есть такой замер?

«Замер до и после» — единственная честная экономика вариативности.

Голосование: должно ли питание быть «лечебным»?

А



Нет. Обычное питание, диетическое — поимённо по показаниям, назначает врач.

Б



Да. Стол дома должен быть лечебным по умолчанию — так безопаснее.

Руки за А. Руки за Б. Возражения — микрофон: самое интересное начнётся здесь.

Четыре шага, чтобы совместить

1



Врач назначает рамку

стол/текстура/ограничения —
поимённо, с пересмотром

2



Внутри рамки — пары

диетический стол тоже имеет
эквиваленты

3



Журнал замен

выбор фиксируется —
защита жителя и врача

4

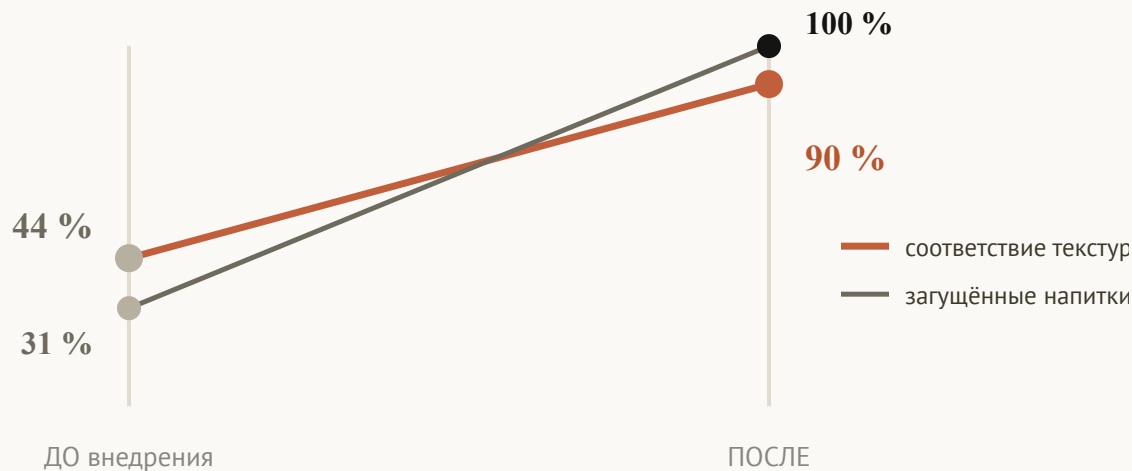


Пересмотр

статистика выбора →
корректировка цикла раз в
квартал

Диета — ограничение множества, а не сжатие до одного блюда.

Обучение работает лучше оборудования



Пять учреждений, шкала IDDSI. Главный барьер — не техника, а осведомлённость смены. Текстуру назначает врач; IDDSI описывает и проверяет консистенцию.



Вспомните жителя, который не говорит. Как он вчера дал понять, что не хочет это блюдо?

Отвернулся? ест только хлеб? доел компот и оставил котлету? — это и была его «заявка».

Кто назовёт один такой сигнал из своего дома? Микрофон.

Где действительно теряются деньги

543 ТОРГА · 4,7 МЛРД ₽



Картель на поставках социально значимых продуктов (ФАС, 2024).

Сигналы: два-три «своих» поставщика, минус доли процента от начальной цены, «проигравший» побеждает в соседнем лоте.

АУТСОРСИНГ: 8 СТРОК



Если кормит подрядчик — вариативность живёт в контракте: группы позиций, гарантия двух вариантов, замены, текстуры, пробы, отчётность.

Пробы, бракераж и ответственность остаются у учреждения — даже когда плита у подрядчика.



Сколько стоит один обед в вашем доме — в рублях? Кто знает точную цифру?

Не «на тысячу проживающих в год». Один обед. Один житель. Сегодня.

Знание цены — начало управления ею. Цифра есть у каждого на калькуляторе приложения 42.

Смежные площадки: наши пересечения

«Право на выбор – есть или нет?»

панель 25.08, 14.30 · в 16.15 — Федермессер: достоинство, «не причинять добро»

«Право быть недееспособным»

25.08 · наш вопрос 5: интересы выявляются, а не назначаются

«Нужны ли врачи в доме?»

дебаты 26.08 · наш вопрос 3: «лечебность» без врача — не забота, а риск

«Сонастройка с опекой – это возможно»

26.08 · наш вопрос 1: опекун — участник выявления воли, не цензор меню

«Как наладить жизнь в доме?»

мозговой штурм 26.08, 16.00 · сразу после нас: ночной интервал, не новое блюдо

«Право на достойный уход»

26.08, параллельно нам · комфортное кормление в конце жизни — тоже право выбора

Что вы уносите с собой

Доклад «Не просто накормить»



250 страниц: право, клиника, экономика, 45 приложений-шаблонов

Калькулятор стоимости



Excel: ваша пара блюд и ваши отходы — за один вечер

Чек-листы и журналы



экспресс-аудит, журнал замен, пищевой паспорт, План Б

Реестр источников



126 записей: право 34 · клиника 48 · практики 44; в тексте — 115 цитирований

Всё открыто — сканируйте QR:



[github.com/qlolp/
seminar-variable-food-2026](https://github.com/qlolp/seminar-variable-food-2026)



Что в ваших домах ломается первым — когда речь заходит о выборе блюд?

Деньги? руки? страх проверки? «у нас особые жители»? начать не с чего?

Каждое «ломается» из зала — готовый пункт повестки для ваших учредителей.

Спасибо. Продолжаем разговор

Евгений Чистяков · ДСО «Серафимовский», Санкт-Петербург

Тимур Нурбаев · ДСО «Тесовый берег», Санкт-Петербург

Материалы сессии — доклад, калькулятор, чек-листы, реестр источников:

github.com/qlolp/seminar-variable-food-2026



Вопросы после сессии — лично и по каналам связи в раздатке.

Шесть вопросов программы — дословно

1. Кто выбирает форму питания — проживающий социального дома или его руководитель?
2. Как формировать меню в условиях жестких нормативно-правовых и финансовых ограничений?
3. Должно ли быть питание в социальных домах «лечебным»?
4. Как совместить понятия «лечебное питание» и «вариативное меню», не ограничивая право проживающего на выбор?
5. Как соблюсти баланс между выбором недееспособного проживающего «что ему есть» и имеющимися у него медицинскими рекомендациями?
6. Как совместить качество продуктов питания и нормирование цен на них при планировании бюджета в условиях рыночной экономики?